Camila Teles
PSICÓLOGA E NEUROPSICÓLOGA

LAUDO PSICOLÓGICO

De Avaliação Neuropsicológica

FELIPE SANT ANNA BARUSSI

Camila Teles de Souza Nunes
Psicóloga, Especialista em Neuropsicologia e Terapia Cognitivo Comportamental
Mestre em Educação e Saúde na Infância e Adolescência

Camila Teles de Souza Nunes – Psicóloga/Neuropsicóloga – CRP: 06/129130
Contato: (11) 95853-9054 E-mail: cnunes18@unifesp.br

Índice

1. Dados de Identificação 3

2. Encaminhamento e Descrição da Demanda 3

3. Procedimentos 4

4. Informações Preliminares 4

5. Observações Clínicas e Comportamento durante a Avaliação 6

6. Descrição e Análise dos Resultados da Avaliação Neuropsicológica 7

6.1 Eficiência intelectual 7

6.2 Processos Atencionais 9

6.3 Memória e Aprendizagem 11

6.4 Funções Executivas 13

6.5 Praxia, Visuopercepção e Visuoconstrução 15

6.6 Linguagem 15

6.7 Aspectos Comportamentais e Emocionais 16

6.8 Instrumentos Complementares 18

7. Conclusão 21

8. Recomendações 22

Camila Teles de Souza Nunes – Psicóloga/Neuropsicóloga – CRP: 06/129130
Contato: (11) 95853-9054 E-mail: cnunes18@unifesp.br

1. Dados de Identificação

Identificação do Paciente

Nome: Felipe Sant Anna Barussi
Data de Nascimento: 17/01/2005
Idade: 20 anos
Sexo: Masculino
Dominância Manual: Destro
Escolaridade: Superior incompleto
Profissão: Estudante

Identificação do Laudo

Período da avaliação: Agosto a Setembro de 2025
Solicitante: Dr. Marcus Ribeiro (CRM 202317SP)
Finalidade: Avaliação Neuropsicológica

Autora: Camila Teles de Souza Nunes (CRP 06/129130)
Qualificações: Psicóloga Clínica e Neuropsicóloga, Doutoranda e Mestre em Ciências - Educação e Saúde na Infância e Adolescência pela UNIFESP, Especialista em Neuropsicologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e possui Qualificação Profissional na Abordagem Neuropsicológica Multidisciplinar em Transtornos do Desenvolvimento pela UNIFESP. Especialista em Terapia Cognitivo Comportamental, formada em Terapia do Esquema pela Wainer psicologia, formada em Reabilitação Neuropsicológica/Cognitiva pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – FMUSP, possui Aprimoramento Profissional em Psicologia Clínica pelo IAMSPE, Educadora Parental Certificada em Disciplina Positiva. Atualmente realiza especialização em Terapia Comportamental Dialética pela VilaELO e especialização em TDAH: Avaliação e intervenção na PUCPR. É pesquisadora vinculada ao NANI (Núcleo de Atendimento Neuropsicológico Infantil e Interdisciplinar) - CPN (Centro Paulista de Neuropsicologia (AFIP-UNIFESP).

2. Encaminhamento e Descrição da Demanda

O paciente procurou pela avaliação neuropsicológica, encaminhado pelo médico psiquiatra Dr. Marcus Ribeiro (CRM 202317SP), com o qual faz acompanhamento, visando através desta compreender o seu perfil cognitivo e psicológico, e com isso poder auxiliar e orientar seu diagnóstico e tratamento. Além de investigar a hipótese diagnóstica de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

Foram obtidas informações clínicas relevantes por meio de entrevistas com Felipe e seus familiares. As principais queixas referem-se a dificuldades de atenção, caracterizadas por erros frequentes e falhas relacionadas à memória, além da presença de sintomas de ansiedade e preocupação recorrente com seu desempenho.

Camila Teles de Souza Nunes – Psicóloga/Neuropsicóloga – CRP: 06/129130
Contato: (11) 95853-9054 E-mail: cnunes18@unifesp.br

3. *Procedimentos*

Avaliação composta por entrevista de anamnese, testes neuropsicológicos e atividades complementares específicas. Foram realizadas aproximadamente 11 sessões, incluindo a sessão de anamnese com o paciente, encontros subsequentes com o mesmo para aplicação dos testes, entrevista com a mãe e uma sessão de devolutiva para apresentação dos resultados. Os encontros tiveram duração de aproximadamente 1 hora. O paciente compareceu sozinho as sessões e declarou as informações supracitadas.

Foram utilizados instrumentos seguindo a resolução do Conselho Federal de Psicologia (CFP) 06/20191. Para testes que apresentam distribuição normal, os z-scores foram obtidos a partir das medidas normativas dos respectivos manuais padronizados ou estudos normativos preliminares e convertidos em percentil mediante tabela estatística padrão2. Para os testes/tarefas cuja distribuição não for normal será realizada interpretação clínica do resultado a partir dos dados do manual e da observação qualitativa da produção do paciente. O cálculo do Zscore foi realizado com fins de apoio à decisão clínica.

Objetivando tornar o documento compreensível foi adotada linguagem interpretativa única[3]. Salienta-se também que esta avaliação é ideográfica, comparando o desempenho do(a) paciente em uma dada função cognitiva com as demais funções, bem como com seu contexto de vida. Para a devida interpretação desses resultados, considera-se a tabela a seguir, a mesma baseia-se no postulado de Benton et al,1994[4].

Desempenho	Descrição
Preservado (Médio, médio superior e superior)	Desempenho **dentro ou acima do esperado** para o padrão de funcionamento cognitivo do (a) paciente, conforme estudos qualitativos e/ou observação clínica.
Médio inferior (Provavelmente comprometido)	Desempenho **abaixo do esperado** para o padrão de funcionamento cognitivo do (a) paciente, conforme estudos qualitativos e/ou observação clínica. Não se considera um prejuízo efetivo, mas ressalta-se alerta clínico e necessidade de manter seguimento e reavaliação neuropsicológica a critério médico. Do percentil 24 até o 6.
Inferior (Comprometido)	Desempenho **comprometido** para seu padrão de funcionalidade Percentil menor ou igual a 5.

4. *Informações Preliminares*

Felipe tem 20 anos de idade, é natural de Curitiba - PR, e atualmente reside sozinho em Roma há aproximadamente dois anos, onde está cursando o 5º semestre do curso de Ciências da Computação aplicada a Inteligência Artificial.

Durante a entrevista de anamnese, relatou perceber dificuldades de atenção e concentração, especialmente em atividades teóricas, como leituras de conteúdos em PDF, nas quais apresenta dificuldade em manter o foco. Ressaltou, contudo, que em atividades práticas consegue sustentar

1 Disponível em: http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/63171370
2 Strauss E, Sherman EMS e Spreen O. A Compendium of Neuropsychological Tests: Administration, Norms, and Commentary. New York: Oxford University Press, 2006.
3 Lezak MD, Howieson DB, Bigler ED e Tranel D. Neuropsychological Assment. New York: Hardcover, 2012.
4 Benton AL, Sivan AB, Hamsher K de S, et al. (1994). Contributions to neuropsychological assessment. A Clinical manual (2nd ed.). New York: Oxford Press.

Camila Teles de Souza Nunes – Psicóloga/Neuropsicóloga – CRP: 06/129130
Contato: (11) 95853-9054 E-mail: cnunes18@unifesp.br

a atenção por longos períodos, chegando a estudar até oito horas consecutivas. Relatou ainda que, em situações de prova, já cometeu erros atribuídos à desatenção. Referiu também, alterações na memória, tanto de curto quanto de longo prazo.

Socialização: Felipe relatou que, de modo geral, seus relacionamentos sociais são adequados, mas se considera introvertido, o que pode ocasionar certa dificuldade para iniciar interações. Apesar disso, informou possuir um número significativo de amigos e consegue manter vínculos de amizade ao longo do tempo. Encontra-se em um relacionamento amoroso há aproximadamente um ano.

Humor e comportamento: Felipe relatou presença de sintomas ansiosos desde a infância. Na época, destacou que ficava facilmente estressado quando as situações não correspondiam às suas expectativas, especialmente em contextos esportivos, nos quais apresentava irritabilidade associada à autocobrança. Atualmente, refere se considerar tranquilo.

Relatou não apresentar comportamentos de hiperatividade, conseguindo permanecer em repouso, embora demonstre necessidade constante de engajamento em atividades, com baixa tolerância ao tédio. Ressaltou não apresentar dificuldades significativas em organização e planejamento, tampouco comportamentos característicos de impulsividade ou inflexibilidade, referindo lidar de maneira adequada com mudanças inesperadas.

Referiu apresentar procrastinação em tarefas que não envolvem obrigação direta, especialmente em projetos pessoais, porém, uma vez iniciado, costuma concluir o que se propôs a fazer. Mencionou episódios de esquecimento de compromissos sociais e tendência a pequenos atrasos, geralmente de cerca de cinco minutos. Apesar disso, relatou entregar seus trabalhos dentro dos prazos estabelecidos, organizando-se previamente e sem necessidade de prorrogar atividades para a madrugada.

História Educacional e Ocupacional: Felipe foi alfabetizado sem dificuldades e não apresentou retenções ao longo da trajetória escolar. Durante o ensino fundamental e médio, manteve bom desempenho acadêmico. Relatou interesse pela leitura e descreveu-se como dedicado aos estudos por obrigação, buscando obter boas notas. Ressaltou que, nessa fase, era metódico, costumava prestar atenção nas aulas, realizar exercícios e estudar em casa.

Na transição para o ensino superior, em Roma, relatou declínio em seu rendimento, atribuído à necessidade de maior desenvolvimento do raciocínio lógico e pensamento crítico. Apesar disso, não chegou a apresentar reprovações, embora tenha precisado refazer algumas provas ao longo do

Camila Teles de Souza Nunes – Psicóloga/Neuropsicóloga – CRP: 06/129130
Contato: (11) 95853-9054 E-mail: cnunes18@unifesp.br

curso. Mencionou que, em algumas ocasiões, o insucesso ocorreu não por falta de conhecimento, mas por erros de distração.

Em relação à experiência ocupacional, trabalhou previamente como assessor de investimentos por cerca de dois anos, em regime remoto. Relatou que, embora tenha cometido erros ocasionais por distração, de modo geral, desempenhou a função de forma satisfatória e sem maiores dificuldades.

Alimentação e sono: Felipe relatou que sua alimentação é adequada, tanto em termos de qualidade quanto de quantidade. Em relação ao sono, informou que anteriormente mantinha padrão regular e satisfatório. Contudo, recentemente percebeu piora na qualidade do sono, relacionada ao fato de manter um relacionamento à distância, o que levou a alterações na rotina por ligações realizadas durante a madrugada. Ressaltou que, quando dorme sozinho, seu sono tende a ser tranquilo.

Histórico clínico / exames / tratamentos prévios e atuais: Em relação aos dados de saúde, Felipe relatou que iniciou acompanhamento psiquiátrico recentemente, motivado pela busca de diagnóstico.

Referiu experiência prévia em psicoterapia por aproximadamente três meses, durante um relacionamento anterior, com o objetivo de lidar com questões pessoais. Informou não estar em uso de medicação no momento.

5. Observações Clínicas e Comportamento durante a Avaliação

Durante a avaliação, Felipe aderiu prontamente à proposta que lhe foi solicitada, demonstrando engajamento e motivação na realização das tarefas, o que refletiu um bom nível de colaboração. Seu comportamento foi adequado ao contexto avaliativo, mostrou-se receptivo às orientações, aceitou as estratégias propostas e foi capaz de realizar adequações comportamentais quando necessário.

Felipe manteve uma boa intensão comunicativa, com iniciativas para diálogos e trocas comunicativas. Ele também sustentou o contato visual, demonstrando habilidades socioemocionais apropriadas, apresentou habilidades adequadas para troca de turnos da fala, ajustando o tom de voz de acordo com o contexto da interação.

Camila Teles de Souza Nunes – Psicóloga/Neuropsicóloga – CRP: 06/129130
Contato: (11) 95853-9054 E-mail: cnunes18@unifesp.br

6. Descrição e Análise dos Resultados da Avaliação Neuropsicológica

6.1 Eficiência intelectual

Escala de Inteligência Wechsler para Adultos (WAIS-III) [5]

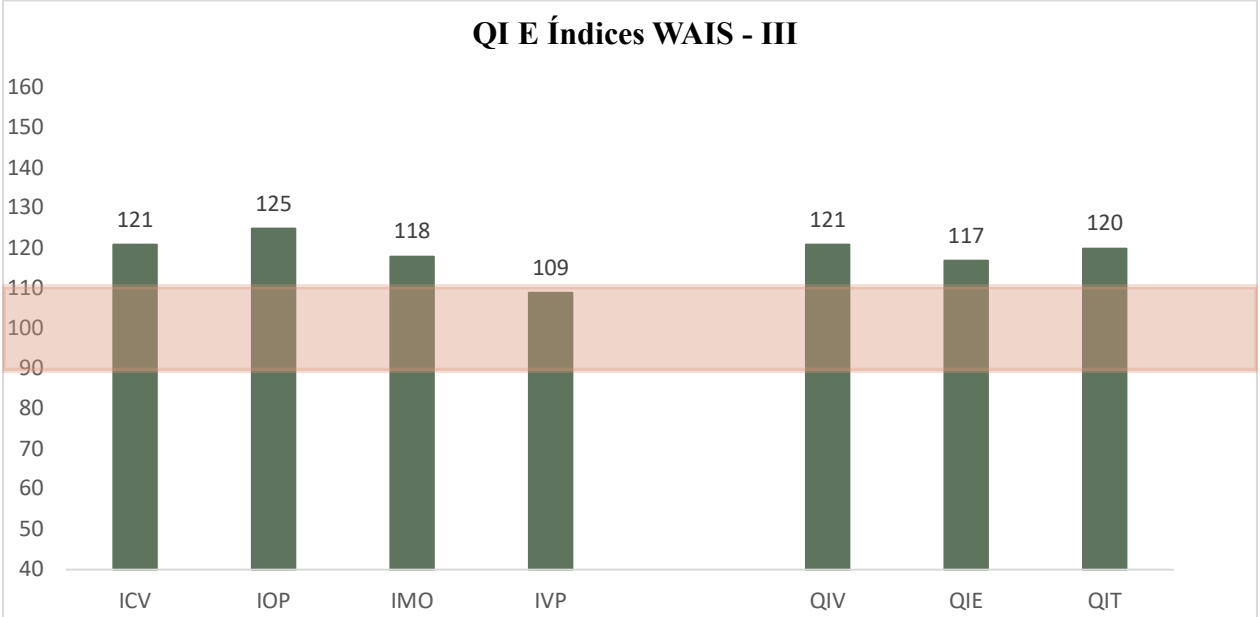

Gráfico 1. **Índice de Compreensão Verbal (ICV):** composto por provas que avaliam as habilidades verbais por meio do raciocínio, compreensão e conceituação. **Índice de Organização Perceptual (IOP):** constituído por atividades que examinam o grau e a qualidade do contato não verbal do indivíduo com o ambiente, assim como a capacidade de integrar estímulos perceptuais e respostas motoras pertinentes, o nível de rapidez com o qual executa uma atividade e o modo como avalia informações viso espaciais. **Índice de Memória Operacional (IMO):** formado por provas que analisam atenção, concentração e memória de trabalho. **Índice de Velocidade de Processamento (IVP):** constitui-se de atividades que avaliam agilidade mental e processamento grafo motor. **Coeficiente de Inteligência Total (QIT)**: avalia o nível geral do funcionamento intelectual.

Escala de Inteligência Wechsler para Adultos (WAIS-III)	Pontos Ponderados	QI Índices Fatoriais	Percentil	Classificação
Índice de Compreensão Verbal	42	121	92	SUPERIOR
Índice de Organização Perceptual	43	125	95	SUPERIOR
Índice de Memória Operacional	40	118	88	MÉDIA SUPERIOR
Índice de Velocidade de Processamento	23	109	73	MÉDIA
QIT - Total	145	120	91	SUPERIOR
QIV -Verbal	81	121	92	SUPERIOR
QIE - Execução	64	117	87	MÉDIA SUPERIOR

Os resultados verificados por meio da Escala de Inteligência Wechsler para Adultos – WAIS III indicaram **Desempenho intelectual global** acima do esperado (QIT:120) quando comparado a

5 Wechsler D. Escala de Inteligência Wechsler para Adultos. 3ª ed. São Paulo: Pearson, 2020.

Camila Teles de Souza Nunes – Psicóloga/Neuropsicóloga – CRP: 06/129130
Contato: (11) 95853-9054 E-mail: cnunes18@unifesp.br

amostra populacional da mesma idade, indicando que Felipe possui capacidade preservada para aprendizagem, raciocinar, resolver problemas, agir intencionalmente, pensar racionalmente e lidar de modo eficaz com o ambiente em que está inserido.

Também obteve desempenho acima do esperado para as habilidades verbais (QIV: 121), e na média superior para as habilidades executivas (QIE: 117). O QIV está relacionado a capacidade de lidar com símbolos abstratos, qualidade da educação formal e estimulação do ambiente, compreensão e fluência verbal. Já o QIE, está relacionado a capacidade de integrar estímulos perceptuais e respostas motoras, capacidade de trabalhar situações concretas, capacidade de avaliar informações visuoespaciais e avaliar o grau e a qualidade de contato não verbal do indivíduo com o ambiente.

O WAIS III também é composto pelos seguintes índices fatoriais:

Índice de Compreensão Verbal: As habilidades de raciocínio verbal e formação de conceitos de Felipe estão acima do esperado, indicando excelente capacidade para compreender situações complexas e expressar-se verbalmente através de conceitos gerais.

Índice de Organização Perceptual: As habilidades de raciocínio fluído, não verbal, de atenção a detalhes e de visuomotora de Felipe também estão acima do esperado, indicando capacidade para compreender padrões visuais e resolver problemas de alta complexidade.

Índice de Memória Operacional: As habilidades de memória operacional de Felipe apresentaram-se dentro da média superior, indicando que ele consegue realizar processos mentais em que necessite reter uma quantidade limitada de informações em prol de um comportamento complexo simultâneo, ou seja manipular informações mentalmente.

Índice de Velocidade de Processamento: As habilidades de velocidade de processamento de Felipe estão dentro do esperado, indicando que ele conseguiu manter o foco dirigido nas atividades que exigiram velocidade de execução, assim como agilidade motora.

Camila Teles de Souza Nunes – Psicóloga/Neuropsicóloga – CRP: 06/129130
Contato: (11) 95853-9054 E-mail: cnunes18@unifesp.br

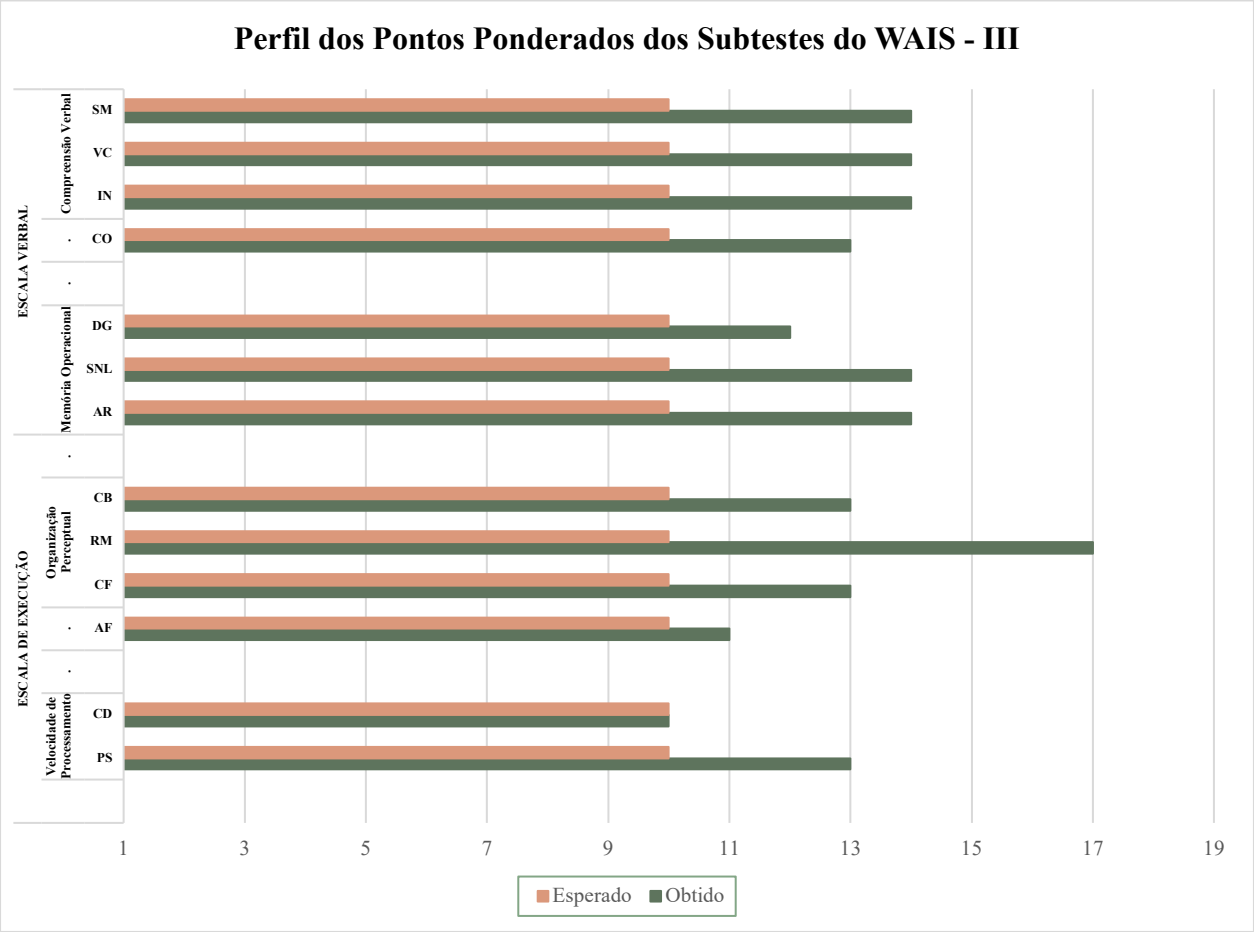

Gráfico 2. **Perfil dos Pontos Ponderados dos Subtestes do WAIS - III:** Semelhanças (SM); Vocabulário (VC); Informação (IN); Compreensão (CO); Dígitos (DG); Sequência de Números e Letras (SNL); Aritmética (AR); Cubos (CB); Raciocínio Matricial (RM); Completar Figuras (CF); Arranjo de Figuras (AF); Código (CD); Procurar Símbolos (PS); Armar Objetos (AO).

6.2 Processos Atencionais

Instrumentos Utilizados	Bruto	Percentil	Classificação
Códigos (WAIS-III) [6]	63	50	MÉDIA
Procurar Símbolos (WAIS-III)	38	84	MÉDIA SUPERIOR
Dígitos (WAIS-III)	17	74	MÉDIA SUPERIOR
Teste de Atenção Concentrada (TEACO-FF) [7]	161	90-99	SUPERIOR/ MUITO SUPERIOR
Teste de Atenção Dividida (TEADI) [8]	170	80-90	MÉDIA SUPERIOR/ SUPERIOR
Teste de Atenção Alternada (TEALT)[9]	126	80	MÉDIA SUPERIOR
D2-R OAP[9]	202	82	ALTO
D2-R: DC	199	92	ALTO
D2 E%	1,49	99	MUITO ALTO
Atenção Concentrada - AC 15 – 5 MIN	95	85-90	MÉDIA SUPERIOR

6 Wechsler D. Escala de Inteligência Wechsler para Adultos. 3ª ed. São Paulo: Pearson, 2020.
7 Rueda, F. J. M., Sisto, F. F. Coleção TEACO-FF - Teste de Atenção Concentrada. 2ª edição São Paulo: Vetor.
8 Rueda, F. J. M. Coleção TEADI E TEALT - Teste de Atenção Dividida e Teste de Atenção Alternada. 2ª edição São Paulo: Vetor.
9 Malloy- Diniz, L.F. d2- R: teste d2 – revisado / Rolf Brickenkamp,Lothar Schimidt-Atzert, DetlevLiepmann; adaptação Leandro Fernandes Malloy-Diniz, Carlos G.F.M, Scholottfeldt; tradução Giselle Muller Roger Welter. 1. Ed. – São Paulo: Hogrefe, 2018.

Atenção Concentrada - AC 15 – 10 MIN	89	65-70	MÉDIA
Atenção Concentrada - AC 15 – 15 MIN	91	65-70	MÉDIA
Atenção Concentrada - AC 15 - TOTAL	275	70-75	MÉDIA

A avaliação da atenção do paciente foi realizada por meio de diferentes instrumentos padronizados, com o objetivo de investigar distintos aspectos desse construto, como atenção concentrada, dividida e alternada. Felipe apresentou desempenho dentro da média ou acima da média em todas as atividades.

Na **atenção concentrada**, que se refere-se à capacidade de manter o foco em estímulos específicos por determinado período de tempo, ele obteve desempenho acima do esperado em duas atividades e desempenho na faixa média em outro teste, que também avalia a atenção concentrada em uma tarefa de longa duração com alta demanda de vigilância.

Na **atenção dividida**, que avalia a capacidade de atender simultaneamente a dois tipos distintos de estímulos, apresentou desempenho entre a faixa média superior e superior, indicando boa capacidade para lidar com tarefas que exigem o monitoramento de mais de uma fonte de informação simultaneamente, o que sugere que, quando demandado a realizar duas tarefas ao mesmo tempo, consegue distribuir a atenção de forma funcional, mantendo um bom nível de desempenho.

Na **atenção alternada**, que avalia a habilidade de alternar o foco atencional entre diferentes tarefas ou estímulos, apresentou desempenho na faixa média superior, o que pode indicar adequada capacidade para realizar alternância entre critérios ou estímulos distintos durante a execução de tarefas.

O desempenho no teste AC-15, nos três blocos (5, 10 e 15 minutos), manteve-se estável, dentro da média, sem queda significativa de rendimento ao longo do tempo, o que indica manutenção adequada da **atenção sustentada**. Esses resultados sugerem que o paciente pode ser capaz de manter o foco por períodos prolongados sem oscilações marcantes de desempenho.

Em teste que avalia **atenção auditiva** e memória de trabalho, apontou um desempenho dentro do esperado, o que denota boa capacidade de manutenção e manipulação de informações verbais em curto prazo, além de controle atencional eficiente para estímulos auditivos.

Durante a execução das tarefas, não foram observadas quantidades significativas de erros ou omissões, evidenciando excelente precisão (D2 E%) na realização das atividades. Esse desempenho sugere boa seletividade atencional, com baixa propensão a falhas impulsivas ou decorrentes de desatenção.

Camila Teles de Souza Nunes – Psicóloga/Neuropsicóloga – CRP: 06/129130
Contato: (11) 95853-9054 E-mail: cnunes18@unifesp.br

De modo geral, apesar das queixas relatadas pelo paciente em relação a dificuldades atencionais no contexto acadêmico, os resultados obtidos sugerem um perfil atencional predominantemente preservado, com excelente desempenho em tarefas visuais simples e sustentadas, e boas habilidades de atenção dividida e alternada.

Além disso, durante a observação clínica, o paciente manteve-se concentrado, engajado e responsivo às demandas propostas, não sendo necessária a repetição de instruções, mesmo em tarefas de maior complexidade e que exigiam maior esforço cognitivo.

6.3 Memória e Aprendizagem

Memória refere-se à habilidade de adquirir, reter (armazenar), evocar informações que foram avaliadas pelas vias de aquisição visual e verbal considerando-se o tempo de aquisição (memória operacional, de curto prazo e de longo prazo).

Quanto a **memória episódica verbal**[10] avaliada por meio de atividade de retenção de memória e aprendizagem, Felipe, demonstrou desempenho dentro do esperado, considerando o índice de aprendizagem, ou seja, foi capaz de adquirir, reter (armazenar), e evocar de forma imediata, informações que lhe foram apresentadas pela via verbal. O que indica que apresenta **capacidade preservada de aprendizado e armazenamento de novas informações verbais**, demonstrando uma curva de aprendizado adequada.

Após elemento distrator e passagem de tempo (**evocação tardia),** também obteve desempenho dentro do esperado, demonstrando adequada retenção da informação aprendida previamente. Seu desempenho quanto ao reconhecimento de informações armazenadas mediante pistas externas foi dentro do esperado, o que pode indicar que o paciente se beneficiou de repetições e de pistas externas.

Seu desempenho, comparado à média esperada a idade, está exposto no gráfico abaixo:

10 Paula. Jonas Jardim de., Malloy-Diniz,L.F. Teste de Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey (RAVLT): Livro de aplicação. 1ª ed. São Paulo: Vetor, 2018.

Camila Teles de Souza Nunes – Psicóloga/Neuropsicóloga – CRP: 06/129130
Contato: (11) 95853-9054 E-mail: cnunes18@unifesp.br

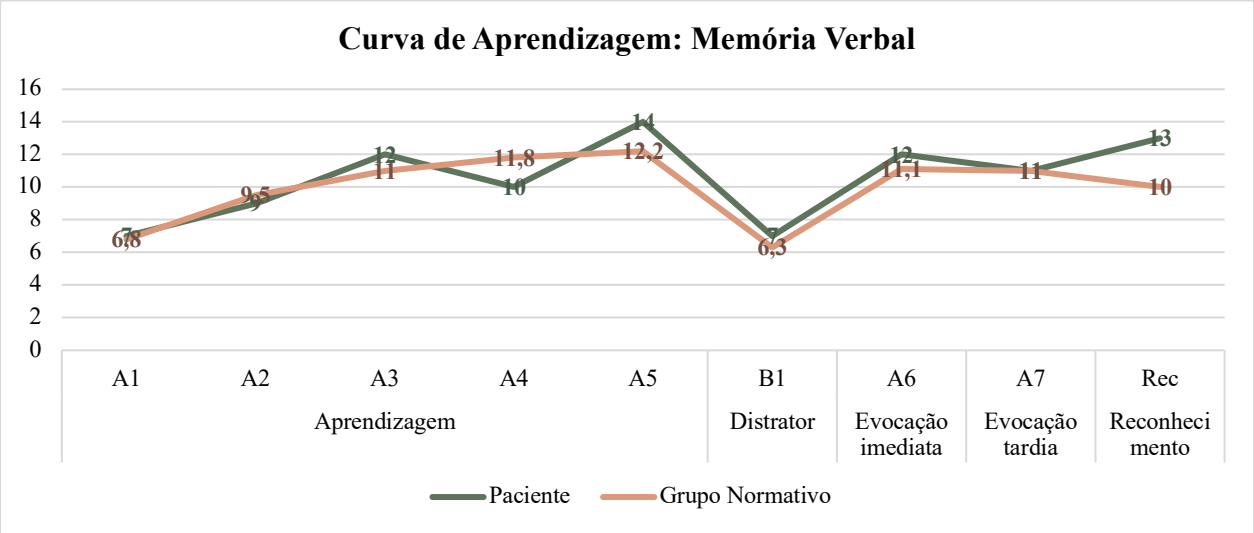

Gráfico 3. Gráfico referente ao desempenho de Felipe durante a prova **RAVLT** (memória auditiva e aprendizagem de palavras).

Em relação a **memória episódica visual**[11] apesar de Felipe ter apresentado curva de aquisição oscilante e dificuldade para evocar algumas imagens de forma imediata, quando apresentadas, demonstrou desempenho adequado considerando o índice de aprendizagem. Na **evocação tardia,** após elemento distrator e passagem de tempo, ele também apresentou desempenho adequado. Na tarefa de reconhecimento, obteve desempenho dentro do esperado, demonstrando adequada recuperação da figura aprendida previamente mediante pistas externas.

Seu desempenho, comparado à média esperada a idade, está exposto no gráfico abaixo:

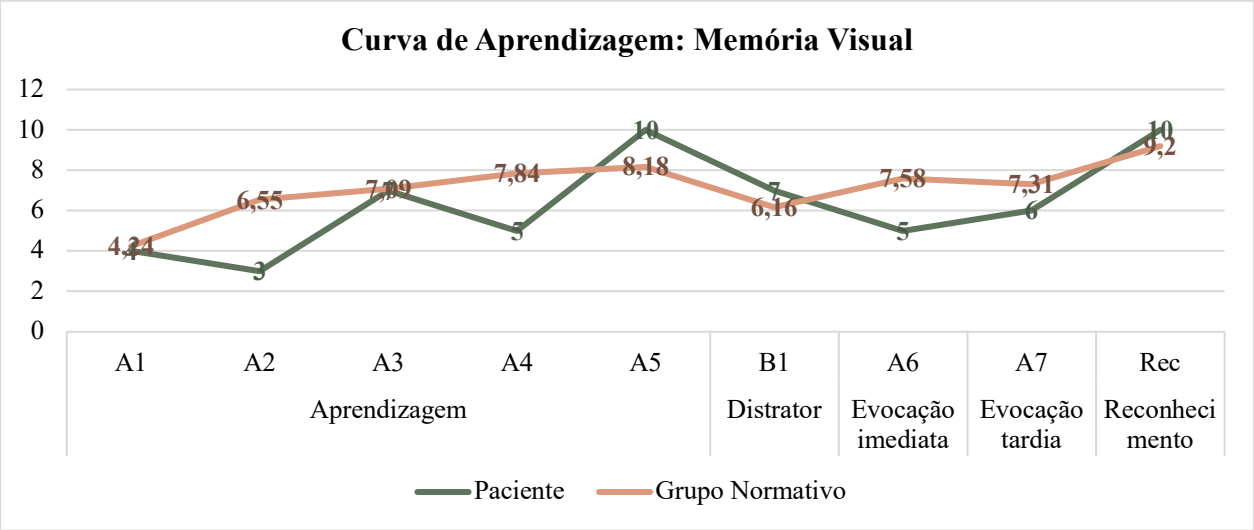

Gráfico 4. Gráfico referente ao desempenho de Felipe durante a prova **RUCHE-M** (memória visual e aprendizagem visuoespacial).

11 Zimmermann N. et al., Teste Ruche de Aprendizagem Visual Modificado. Editora Memnon, 2019.

Na avaliação da **memória de curto prazo verbal** e **memória de curto prazo visual**, apresentou desempenho dentro do esperado, expressando que Felipe possui uma adequada capacidade de memória imediata tanto verbal quanto visual.

Na avaliação de **memória de longo prazo semântica** em tarefas de análise de aspectos verbais, em que Felipe precisou recordar memórias aprendidas em contexto acadêmico, como o conceito de palavras, recordar experiências de vida/culturais e hipotetizar soluções para situações problemas, e em tarefas que precisou verbalizar respostas sobre conhecimentos gerais obteve desempenho acima do esperado.

Instrumentos Utilizados	Bruto	Percentil	Classificação
Vocabulário (WAIS-III) [12]	49	90	SUPERIOR
Informação (WAIS-III)	22	90	SUPERIOR
Sequência de Números e Letras (WAIS-III)	13	90	SUPERIOR
Dígitos (WAIS-III)	17	74	MÉDIA SUPERIOR

6.4 Funções Executivas

Instrumentos Utilizados	Bruto	Percentil	Classificação
Sequência de Números e Letras (WAIS-III) [13]	13	90	SUPERIOR
Aritmética (WAIS-III)	17	90	SUPERIOR
Semelhanças (WAIS-III)	33	90	SUPERIOR
Compreensão (WAIS-III)	27	84	MÉDIA SUPERIOR
Raciocínio Matricial (WAIS-III)	26	99	MUITO SUPERIOR
Arranjo de Figuras (WAIS-III)	15	63	MÉDIA
Dígitos (WAIS-III)	17	74	MÉDIA SUPERIOR
FDT: Escolha - Tempo[14]	34	> 50 < 75	MÉDIA
FDT: Alternância – Tempo	42	> 50 < 75	MÉDIA
FDT: Inibição	15	> 25 < 50	MÉDIA
FDT: Flexibilidade	23	> 25 < 50	MÉDIA
TOL-BR – Torre de Londres	55	99	SUPERIOR

As funções executivas são processos cognitivos responsáveis pela organização, planejamento e execução de atividades, são habilidades que permitem o sujeito a direcionar comportamentos para alcançar metas, resolver conflitos imediatos, controlar comportamentos inadequados em determinados contextos e agir de maneira flexível. Incluem iniciação de tarefas, memória de

12 Wechsler D. Escala de Inteligência Wechsler para Adultos. 3ª ed. São Paulo: Pearson, 2020.
13 Wechsler D. Escala de Inteligência Wechsler para Adultos. 3ª ed. São Paulo: Pearson, 2020.
14 Sedó M, Paula JJ, Ma, Malloy-Diniz LF. Five Digit Test. Adaptação e padronização brasileira Jonas Jardim de Paula e Leandro Fernandes Malloy-Diniz. São Paulo: Hogrefe CETEPP, 2015.

Camila Teles de Souza Nunes – Psicóloga/Neuropsicóloga – CRP: 06/129130
Contato: (11) 95853-9054 E-mail: cnunes18@unifesp.br

trabalho, automonitoramento, inibição de impulsos, flexibilidade cognitiva, raciocínio e regulação de comportamento.

O desempenho de Felipe em tarefas de **memória operacional** situou-se dentro do esperado, demonstrando que ele possui boa habilidade para manipular mentalmente informações breves e objetivas. Na memória operacional verbal, no subteste Dígitos – Ordem Inversa, o paciente foi capaz de manipular corretamente até cinco dígitos, e no Corsi – Ordem Inversa, ele conseguiu reter e manipular até oito blocos. Esses resultados podem indicar uma boa capacidade de manipulação ativa de informações, principalmente no plano visuoespacial.

Em teste que avalia as funções executivas, particularmente a capacidade de formular e implementar estratégias eficientes para alcançar objetivos específicos, além de medir a capacidade de antecipar e organizar ações de maneira lógica, obteve desempenho acima da média esperada, indicando alta capacidade de **planejamento e resolução de problemas** complexos.

Em tarefa de **raciocínio lógico e sequencial** foi capaz de ordenar e priorizar elementos centrais e detalhes importantes para a compreensão do todo. Em tarefa de **raciocínio e abstração verbal**, demonstrou excelente habilidade para extrair categorias entre palavras apresentadas a ele, com desempenho acima do esperado. E quanto as tarefas de **raciocínio visual**, também apresentou desempenho acima do esperado, foi capaz de formular relações lógicas, em tarefa que precisou analisar uma matriz-estímulo e preencher uma lacuna com a opção mais adequada.

Quanto ao **controle Inibitório,** o desempenho quantitativo em atividades que requisitaram essa habilidade, demonstrou-se dentro do esperado para sua faixa etária. Durante as sessões, observou-se que o paciente demonstrou habilidade tanto na inibição quanto no monitoramento de seu comportamento, tanto por via verbal como motora, não incorreu em erros por intrusões de informações inadequadas ou por quebras de regras, indicando que ele foi capaz de se adequar às demandas solicitadas. No dia a dia o paciente também não refere comportamentos impulsivos. Esses resultados sugerem que Felipe apresenta um desenvolvimento adequado em termos de controle inibitório e que essa habilidade não representa uma limitação em sua vida diária, o que sugere uma tendência a planejar e ponderar suas escolhas com bastante cautela.

No que se refere a **flexibilidade cognitiva**, Felipe demonstrou um desempenho dentro do esperado para sua faixa etária em atividades quantitativas. Em tarefa de classificação de cartas que visa a avaliação das **funções executivas**, ele apresentou desempenho satisfatório demonstrando boa capacidade de flexibilidade cognitiva, raciocínio abstrato e adaptação às mudanças de regra. Foi

Camila Teles de Souza Nunes – Psicóloga/Neuropsicóloga – CRP: 06/129130
Contato: (11) 95853-9054 E-mail: cnunes18@unifesp.br

capaz de identificar padrões e modificar estratégias de forma eficaz ao longo da tarefa, indicando preservação das funções executivas relacionadas à resolução de problemas e controle inibitório.

6.5 Praxia, Visuopercepção e Visuoconstrução

Instrumentos Utilizados	Bruto	Percentil	Classificação
Completar Figuras (WAIS-III) [15]	22	84	MÉDIA SUPERIOR
Cubos (WAIS-III)	45	84	MÉDIA SUPERIOR

A praxia visuoconstrutiva refere-se à habilidade de perceber, analisar e organizar estímulos visuais, integrando-os à coordenação motora fina para a construção de representações no plano bidimensional ou tridimensional. Esse processo envolve percepção visual acurada, planejamento espacial, coordenação visuomotora, aprendizado de padrões e capacidade de distinguir figura e fundo.

O paciente apresentou desempenho na faixa média superior nas tarefas que avaliaram essas habilidades, demonstrando adequada análise visual, organização perceptiva e coordenação motora fina. Obteve também, desempenho dentro da média superior em tarefas tridimensionais que exigiram planejamento construtivo, segmentação (decomposição mental) e transposição de modelos gráficos bidimensionais para construções tridimensionais com material concreto, confirmando habilidade visuoconstrutiva preservada.

6.6 Linguagem

Instrumentos Utilizados	Bruto	Percentil	Classificação
Teste de Nomeação de Boston[16]	55	55	MÉDIA
Vocabulário (WAIS-III) [17]	49	90	SUPERIOR
Informação (WAIS-III)	22	90	SUPERIOR
Semelhanças (WAIS - III)	33	90	SUPERIOR

Quanto a **linguagem receptiva**, Felipe demonstrou capacidade de compreensão preservada, mesmo para conteúdos mais complexos, não necessitando de repetição de comandos.

15 Wechsler D. Escala de Inteligência Wechsler para Adultos. 3ª ed. São Paulo: Pearson, 2020.
16 MIOTTO, E.C. et al. Development of an adapted version of the Boston Naming Test for Portuguese speakers. Revista Brasileira de Psiquiatria, v. 32, no 3 (set), 2010.
17 Wechsler D. Escala de Inteligência Wechsler para Adultos. 3ª ed. São Paulo: Pearson, 2020.

Quanto a **linguagem expressiva**, durante a avaliação, o paciente demonstrou uso adequado do vocabulário, com formação de frases gramaticalmente corretas e boa organização das ideias, permitindo comunicação clara e coerente. Não apresentou alteração articulatória ou distorção na produção dos fonemas.

Além disso, os processos de nomeação encontram-se preservados.

6.7 Aspectos Comportamentais e Emocionais

Abaixo seguem as descrições dos resultados da paciente em relação as escalas e questionários de autorrelato e autopreenchimento, **contudo tais dados devem ser interpretados com cautela, visto que esses instrumentos são preenchidos pela própria paciente de acordo com sua auto-observação.** Desta forma, é importante considerar que **a percepção subjetiva da paciente pode não refletir com precisão a frequência e intensidade dos sintomas** uma vez que estes podem ser influenciados por fatores como o contexto social, o estado de saúde mental e outros eventos estressantes.

- **Inventário de Depressão de Beck - BDI-II**

Em escala de autopreenchimento que mede a intensidade e a gravidade dos sintomas depressivos, não foram identificados sintomas de humor deprimido.

- **Escala Baptista de Depressão – EBADEP-A**

A aplicação da escala EBADEP-A, que avalia a presença e intensidade de sintomas depressivos, também não indicou a presença de sintomatologia depressiva.

- **Escala Hamilton de Ansiedade**

Em escala de avaliação de sintomas ansiosos em diferentes domínios obteve pontuação total de 9 pontos, não indicando presença clinicamente significativa de sintomas ansiosos. Observa-se apenas discreta tensão ou preocupação situacional, compatível com níveis usuais de ansiedade.

Camila Teles de Souza Nunes – Psicóloga/Neuropsicóloga – CRP: 06/129130
Contato: (11) 95853-9054 E-mail: cnunes18@unifesp.br

- **Escala de Desregulação Emocional – EDE-A**

Foi utilizada também, uma escala que avalia a desregulação emocional relacionada aos pensamentos, sentimentos e comportamentos que ocorrem diante de algum evento da vida que gera tristeza. Ela é composta de quatro dimensões: estratégias adequadas de enfrentamento; externalização da agressividade; pessimismo; e paralisação.

Os resultados obtidos indicam que o paciente apresenta um **funcionamento emocional relativamente adaptativo**. O fator estratégias adequadas de enfrentamento indica que Felipe consegue eventualmente soluções adequadas para a autorregulação, no entanto, nem sempre obtêm sucesso. Os dados do fator externalização da Agressividade sugerem que ele conseguirá eventualmente, ter controle sobre os seus impulsos. No entanto, é possível que, em algumas situações, ele não externalize adequadamente as emoções. O fator pessimismo indica que ele tem uma visão sobre si com algum otimismo e algum pessimismo, não podendo caracterizar-se como alguém que acredita que superará ou que se vê sem recursos. E por fim, o resultado do fator paralisação indicando que ele consegue engajar-se em determinadas situações, porém, eventualmente, pode não ter sucesso no estabelecimento de rotas alternativas em prol da resolução.

Escala de Desregulação Emocional[18]	Bruto	Percentil	Classificação
Estratégias adequadas de enfrentamento	6	60	Médio-Alto
Externalização da Agressividade	1	25	Médio-Baixo
Pessimismo	2	30	Médio-Baixo
Paralisação	6	40	Médio-Baixo

- **Bateria Fatorial de Personalidade (BFP)** [19]

A Bateria Fatorial de Personalidade, é um instrumento baseado no modelo dos cinco grandes fatores, que se propõe a avaliar diferentes dimensões da personalidade, com base na percepção que o paciente tem de si mesmo.

Os resultados apontam para um perfil de personalidade marcado por estabilidade emocional e independência afetiva, com baixa vulnerabilidade e tendência a vivenciar emoções positivas. Apresenta padrões adaptativos de instabilidade emocional, energia e depressão, além de

18 Baptista, M. N., Noronha, A. P. P., & Bonfá-Araujo, B. EDE-A Escala de Desregulação Emocional: versão adultos; EDE-IJ Escala de Desregulação Emocional: versão infantojuvenil: 1ª ed. São Paulo: Vetor Editora, 2023.
19 NUNES, C. H. S.; HUTZ, C. S.; NUNES, M. F. O. Bateria Fatorial de Personalidade: manual técnico. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2014.

Camila Teles de Souza Nunes – Psicóloga/Neuropsicóloga – CRP: 06/129130
Contato: (11) 95853-9054 E-mail: cnunes18@unifesp.br

comunicação, altivez e interações sociais em níveis médios, sugerindo habilidades sociais equilibradas. Destaca-se dinamismo baixo, tendendo a se concentrar em um pequeno número de atividades simultâneas e não precisa estar constantemente envolvido em várias atividades para sentir-se bem. Na dimensão socialização, mostra baixa amabilidade, mas confiança nos outros e pró-sociabilidade médias, indicando autocentramento moderado com capacidade de estabelecer vínculos. Em realização, apresenta competência e prudência médias, mas baixo comprometimento com tarefas detalhadas. Quanto à abertura, evidencia postura conservadora, baixa curiosidade e pouca busca por novidades, com liberalismo médio. No conjunto, os resultados sugerem um perfil emocionalmente estável, socialmente adaptativo, com preferência por rotina e engajamento seletivo em atividades, o que pode influenciar sua forma de se organizar, iniciar e concluir projetos.

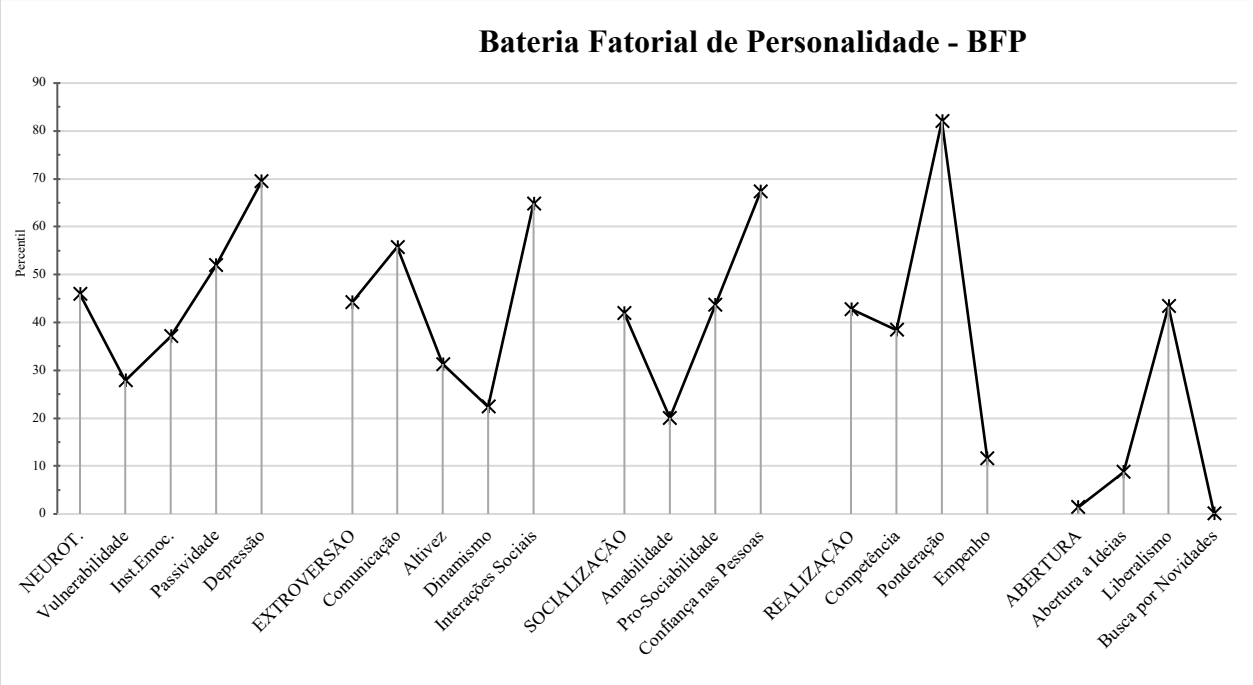

Gráfico 5. Bateria Fatorial de Personalidade - BFP: Perfil do Respondente – Percentil

6.8 Instrumentos Complementares

Abaixo seguem as descrições dos resultados do paciente em relação a outras escalas e questionários de autorrelato e autopreenchimento, **contudo tais dados devem ser interpretados com cautela, visto que esses instrumentos são preenchidos pelos próprios pacientes de acordo com sua auto-observação.** Desta forma, é importante considerar que **a percepção subjetiva do paciente pode não refletir com precisão a frequência e intensidade dos sintomas** uma vez que estes

podem ser influenciados por fatores como o contexto social, o estado de saúde mental e outros eventos estressantes.

- **Escala de Avaliação de Disfunções Executivas de Barkley - BDEFS**

Em escala que permite verificar possíveis déficits das funções executivas nas atividades cotidianas e sintomas do TDAH, não foram observados comprometimentos significativos.

Escala de Avaliação de Disfunções Executivas de Barkley - BDEFS[20]	Bruto	Percentil	Classificação
BDEFS: Gerenciamento de tempo	41	50	Sem Prejuízo
BDEFS: Organização/resolução de problemas	46	50	Sem Prejuízo
BDEFS: Autocontrole	26	20	Sem Prejuízo
BDEFS: Motivação	15	25	Sem Prejuízo
BDEFS: Regulação emocional	23	45	Sem Prejuízo
BDEFS: Total de FE	151	35	Sem Prejuízo
BDEFS: Total de sintomas de FE	13	45	Sem Prejuízo
BDEFS: Índice TDAH-FE	16	25	Sem Prejuízo

- **Escala de Prejuízos Funcionais – EPF-TDAH**

Felipe também respondeu a uma escala de prejuízos funcionais, na qual não foram identificados comprometimentos significativos em nenhuma das áreas avaliadas.

Escala de Prejuízos Funcionais – EPF-TDAH[21]	Bruto	Escore T	Classificação
EPF-TDAH: Acadêmica	7	46	Sem Prejuízo Funcional
EPF-TDAH: Profissional	5	45	Sem Prejuízo Funcional
EPF-TDAH: Afetivo-sexual	12	55	Sem Prejuízo Funcional
EPF-TDAH: Doméstica	10	59	Sem Prejuízo Funcional
EPF-TDAH: Social	11	55	Sem Prejuízo Funcional
EPF-TDAH: Financeira	1	41	Sem Prejuízo Funcional
EPF-TDAH: Saúde	6	47	Sem Prejuízo Funcional
EPF-TDAH: Trânsito	3	54	Sem Prejuízo Funcional
EPF-TDAH: Risco legal	0	48	Sem Prejuízo Funcional

- **ASRS-18**

A análise de escala que investiga sintomas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade evidenciou pontuação abaixo do ponto de corte clínico, não indicando a presença de sintomas

20 Barkley RA. Escala de Avaliação de Disfunções Executivas de Barkley-BDEFS: Adaptação brasileira da Barkley Deficits In Executive Functioning Scale (BDEFS) por Victor P. Godoy, Paulo Mattos e Leandro F. Malloy Diniz. 1ª ed. São Paulo: Hogrefe, 2018.
21 Oliveira, APA, Nascimento E. Escala de Prejuízos Funcionais (EPF- TDAH): 1ª ed. São Paulo: Hogrefe, 2016.

Camila Teles de Souza Nunes – Psicóloga/Neuropsicóloga – CRP: 06/129130
Contato: (11) 95853-9054 E-mail: cnunes18@unifesp.br

significativos de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade, tanto na versão de autorrelato, quanto na versão respondida pelos pais. Esse resultado indica que as dificuldades relatadas pelo paciente não configuram padrão compatível com TDAH, podendo estar relacionadas a fatores situacionais, emocionais ou de estilo de funcionamento pessoal.

ASRS-18 [22]	Ponto de corte	Sintomas presentes	Classificação
Desatenção (Pais)	5 de 9 sintomas	0	Sem Sintomas
Hiperatividade	5 de 9 sintomas	0	Sem Sintomas
Desatenção (Paciente)	5 de 9 sintomas	3	Baixa Frequência
Hiperatividade	5 de 9 sintomas	1	Baixa Frequência

- **Escala de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade – ETDAH-AD**

Esta escala contribui na identificação dos vários sintomas envolvidos no TDAH, avaliando os fatores: desatenção; impulsividade; aspectos emocionais; autorregulação da atenção, da motivação e da ação; e hiperatividade. Felipe apresentou escores majoritariamente dentro da média para os diferentes fatores da escala. Esses dados sugerem que, apesar de queixas subjetivas de dificuldade de atenção, seus sintomas nesse domínio não se apresentam clinicamente significativos; indica baixo nível de impulsividade e equilíbrio emocional adequado; indica leve dificuldade em autorregular a atenção e motivação, mas sem prejuízo funcional significativo; e sugere tendência a manter-se ativo e engajado nas atividades, embora não se refira a comportamento motor excessivo ou desorganização significativa. No conjunto, os resultados não indicam comprometimento clínico significativo, sendo compatíveis com o funcionamento cotidiano relatado por Felipe.

Escala de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade – ETDAH-AD[23]	Bruto	Percentil	Classificação
Fator 1 - Desatenção (D)	37	55	Média
Fator 2 - Impulsividade (I)	25	> 20 < 25	Inferior
Fator 3 - Aspectos Emocionais (AE)	3	25	Média Inferior
Fator 4 - Autoregulação da Atenção, Motivação e Ação (AMAA)	15	30	Média Inferior
Fator 5 - Hiperatividade (H)	16	70	Média Superior

22 Mattos P, Segenreich D, Saboya E, Louzã M, Dias G, Romano M. Adaptação Transcultural para o Português da Escala Adult Self-Report Scale (ASRS-18, versão1.1) para avaliação de sintomas do Transtorno de Déficit de Atenção / Hiperatividade (TDAH) em adultos. Revista Brasileira de Psiquiatria (in press).
23 Benczik E.B.P. Escala de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade - ETDAH-AD: versão adolescentes e adultos. 1ª ed. São Paulo: Vetor, 2013.

Camila Teles de Souza Nunes – Psicóloga/Neuropsicóloga – CRP: 06/129130
Contato: (11) 95853-9054 E-mail: cnunes18@unifesp.br

7. Conclusão

Os resultados obtidos na avaliação indicaram uma capacidade cognitiva global preservada, revelando recursos intelectuais acima do esperado para sua faixa etária (QIT Total – 120), associado a um desempenho acima do esperado em relação ao raciocínio visual, raciocínio e abstração verbal, atenção concentrada, memória de longo prazo semântica, e planejamento e resolução de problemas.

A comparação de seu desempenho, entre as diversas áreas avaliadas, evidenciou como funções preservadas (média e média superior): processos atencionais em relação a atenção alternada e atenção dividida; funções executivas quanto a memória operacional, flexibilidade cognitiva, controle inibitório e velocidade de processamento; processos de memória quanto a memória episódica verbal (retenção e evocação de palavras), memória episódica visual (retenção e evocação de figura), memória de curto prazo visual e memória de curto prazo verbal (armazenamento); e praxia visuoconstrutiva.

Quanto a linguagem oral, estão preservados os aspectos expressivos e compreensivos.

Quanto aos aspectos emocionais e comportamentais, observou-se predomínio de um perfil com funcionamento afetivo globalmente estável, com baixa vulnerabilidade emocional, reduzida propensão a quadros ansiosos ou depressivos e adequada regulação do humor.

Considerando o conjunto dos dados, observa-se um padrão cognitivo superior à média, com evidências de elevada capacidade intelectual, excelente pensamento abstrato, raciocínio lógico consistente e habilidades destacadas para resolução de problemas.

Desta forma, em relação as queixas atencionais, os resultados obtidos na avaliação não indicam um padrão compatível com TDAH no momento. As dificuldades referidas pelo paciente podem estar associadas a fatores situacionais e emocionais, bem como a alterações recentes no padrão de sono, relacionadas ao período de adaptação à vida em outro país. Apesar das queixas cognitivas, o paciente vem atendendo adequadamente às demandas acadêmicas, ocupacionais, funcionais e sociais esperadas. Observa-se ainda a presença de traços de autocobrança e autoexigência elevadas, que podem intensificar sua percepção subjetiva de dificuldade e aumentar o nível de autocrítica diante de exigências de desempenho.

Camila Teles de Souza Nunes – Psicóloga/Neuropsicóloga – CRP: 06/129130
Contato: (11) 95853-9054 E-mail: cnunes18@unifesp.br

8. Recomendações

- ✓ Retorno ao psiquiatra a fim de apresentar e discutir os resultados da avaliação neuropsicológica;
- ✓ Terapia Cognitivo Comportamental para psicoeducação sobre padrões de exigência pessoal e autocrítica, visando maior equilíbrio entre desempenho e bem-estar emocional.

VALIDADE: Conforme normas do Conselho Federal de Psicologia este documento e os dados para sua produção possui tempo de guarda de 5 anos. Ressalta-se que, o ser humano possui uma natureza dinâmica; não definitiva e não cristalizada. Sendo assim, os resultados aqui expostos dizem respeito ao funcionamento das funções cognitivas, como também, da personalidade, humor e afetividade de Felipe no momento presente, podendo haver alterações posteriores, dependendo das contingências ambientais vivenciadas e/ou do (s) acompanhamento (s) recebido (s).

Este documento não poderá ser utilizado para fins diferentes do apontado em sua finalidade. Possui caráter sigiloso e se trata de documento extrajudicial, de modo que o(s) psicólogo(s) não pode se responsabilizar pelo uso dado ao laudo após a sua entrega em entrevista devolutiva.

São Paulo, 15 de outubro de 2025.

Camila Teles S. Nunes
Psicóloga
CRP-06/129130

Camila Teles de Souza Nunes
Psicóloga Clínica e Neuropsicóloga (CRP:06/129130)
Doutoranda e Mestre em Ciências – Ed. e Saúde na Infância e Adolescência pela UNIFESP
Especialista em Terapia Cognitivo Comportamental
Especialista em Neuropsicologia - Santa Casa de São Paulo
Reabilitação Neuropsicológica - Hospital das Clínicas FMUSP
Educadora Parental Certificada em Disciplina Positiva
Qualificação Profissional na Abordagem Neuropsicológica
Multidisciplinar em Transtornos do Desenvolvimento pela UNIFESP
Aprimoramento Profissional em Psicologia Clínica pelo IAMSPE
Formação em Terapia do Esquema
Especialização em Terapia Comportamental Dialética (em andamento)
Pós-graduação em TDAH: Avaliação e intervenção (em andamento)